

1. SELEÇÃO, PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

ARTF1. Configuração das sessões de levantamento de requisitos

ID	PONTOS DE VISTA ¹	OBJETIVOS ²	TÉCNICA SELECIONADA ³	FORMATO DE REGISTRO DA SESSÃO ⁴	LOCAL, DATA E HORA	ESTADO ⁵
SL 1	Recepcionista da UBS	Identificar as principais atividades realizadas na recepção, compreender a rotina diária do seu funcionamento completo e o processo de cadastro de pacientes normais e prioritários.	Entrevista	Arquivo word contendo as perguntas e respostas: "Entrevista - Recepcionista.docx"	Sítio Santa Catarina, 14/10/2025 à 21/10/2025, 15:00.	Concluída
SL 2	Agente Comunitário de Saúde (ACS)	Compreender as atividades do agente de saúde durante as visitas domiciliares, bem como no acompanhamento e na coleta de dados e informações sobre os pacientes.	Entrevista	Conversa via WhatsApp, depois repassadas para um arquivo em PDF: "Entrevista - ACS.pdf"	Sítio Santa Catarina, 14/10/2025, 14:30 às 17:30.	Concluída

ARTF2. Preparação dos artefatos analíticos de levantamento

ID	ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES PRESENTES NO ARTEFATO DE REGISTRO ANALÍTICO
SL 1	A recepcionista da Unidade Básica de Saúde do Sítio Santa Catarina, trabalha há seis anos no local. Ela escolheu a área por gostar de ajudar as pessoas e contribuir com o bem-estar da comunidade. Sua rotina se inicia às sete da manhã e termina por volta de uma da tarde, de segunda a sexta-feira. Suas atividades se resumem em realizar cadastros de pacientes e agendamentos para consultas, vacinas, curativos ou exames quando necessário, fazendo o uso do sistema PEC. Além do uso do sistema para realizar as tarefas rotineiras, ela também recorre a fichinhas de papel para controlar a fila e as prioridades. O atendimento é organizado por ordem de chegada, com prioridade para gestantes, idosos, pessoas com deficiências e casos de urgência, identificados tanto no sistema quanto nas fichas. O sistema auxilia parcialmente nesse controle, mas ainda não oferece uma visualização prática da fila nem permite reorganizar facilmente as prioridades, o que obriga a realização de ajustes manuais. Ela relatou também que, embora o sistema PEC possibilita visualizar os pacientes em espera, ainda existe uma

¹ identificados na caracterização de pontos de vista, no ARTF 2

² obrigatoriamente deve haver uma sessão c/ objetivo de realizar a primeira conversa com o cliente

³ entrevista, workshop, questionário, brainstorming, observação direta, inspeção (documentos e ferramentas), etnografia, prototipação, JAD

⁴ apontamentos escritos, áudio, vídeo, fotos. Coloque o nome do arquivo.

⁵ preparando, agendada, em andamento, concluída, cancelada.

	dependência de anotações manuais. Em situações de alta demanda ou lentidão do sistema, fichas prioritárias podem chegar a serem atendidas fora da ordem, sendo necessário reorganizar o atendimento. E em casos de perda de informações, que são raros, há dificuldade quando os cadastros estão incompletos ou desatualizados. Entre as sugestões de melhorias feitas por ela durante a entrevista, ela cita a criação de uma interface mais clara para visualização da fila, a separação automática das prioridades e o aprimoramento do desempenho do sistema, o que possibilitaria um atendimento mais agradável. Além disso, ela considera um dia eficiente quando a fila anda rápido, as prioridades são respeitadas e o expediente finaliza sem atrasos. Em dado momento, ela diz que, apesar das limitações do sistema PEC, ela reconhece que o sistema digital trouxe avanços em relação ao antigo processo (antes os cadastros eram realizados no papel de forma manual) e destaca a importância da paciência e da atenção para garantir um atendimento humanizado e eficiente. Por fim, ela relatou que o principal desafio é lidar com a alta demanda e com a lentidão do sistema que ela utiliza atualmente, o que exige paciência e organização para manter um bom atendimento. Além disso, a recepcionista citou que durante o trabalho, ela interage principalmente com os pacientes, médicos e a equipe de enfermagem, a fim de garantir o fluxo dos atendimentos.
SL 2	A agente comunitária de saúde, Elenilda, atua há 31 anos na área. Sua rotina se inicia às oito horas da manhã e é composta por visitas domiciliares nas quais é coletado informações sobre as famílias, verificação de peso, altura e cartões de vacinação das crianças, além de acompanhar gestantes e pacientes com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Nesses casos, ela observa se os pacientes estão fazendo o uso correto das medicações e reforça a importância do acompanhamento mensal na UBS para aferição da pressão arterial e glicemia. Quando se trata de pacientes acamados, ela avalia as condições de saúde, de cuidado e alimentação, verificando se há necessidade de visita médica domiciliar. A coleta das informações é feita durante as visitas e os dados que são obtidos, são registrados em um tablet. No entanto, essas informações não são enviadas automaticamente à recepção. O repasse ocorre de forma manual, em reuniões semanais com a enfermeira, que insere os dados coletados pela ACS no prontuário dos pacientes. Um dos pontos críticos destacados por Elenilda é a dificuldade enfrentada pelos moradores para conseguir atendimento médico, já que a unidade oferece apenas 25 fichas por dia. Por isso, muitos pacientes chegam de madrugada para garantir vaga, enquanto outros enfrentam dificuldades de transporte e precisam se deslocar a pé até a UBS. Ela também mencionou que existem problemas de comunicação e organização entre os pacientes e a recepção, sugerindo que, quando as fichas se esgotarem, que ao todo são 25, seja feita uma triagem para identificar e atender casos urgentes, mesmo fora do limite total. As ferramentas utilizadas em seu trabalho incluem celular, tablet, computador da UBS e fichas de papel, demonstrando a existência entre métodos digitais e manuais. Quanto ao relacionamento que ela possui com a recepção, relatou que o contato ocorre principalmente para retirar exames marcados, e fazer a entrega dos mesmos aos pacientes pessoalmente. Apesar de considerar esse processo útil, apontou que os atrasos na marcação de exames feitos pela recepção prejudicam a continuidade do atendimento, evidenciando a falta de integração entre os setores. Por fim, durante a entrevista, ela relatou que as situações mais difíceis e estressantes de seu trabalho ocorrem quando encontra pacientes que não seguem orientações médicas, negligenciam o uso de medicamentos ou vivem em situações precárias de cuidado, além de observar crianças com vacinas atrasadas. Essas circunstâncias causam frustração e preocupação, pois comprometem o objetivo principal do seu trabalho, que é promover a prevenção e o bem-estar da comunidade.

ARTF3.Registro das sessões de levantamento de requisitos

ID	LINK
SL 1	▶ Entrevista Recepcionista
SL 2	▶ Entrevista ACS

